

医療PDFテスト文書B

テーマ: 肺炎の初期評価と再評価

1. 概要

本資料は、肺炎の初期診療を題材にした日本語PDFのサンプルです。文章主体で読み進められる構成にしつつ、フロー図、表、棒グラフ、概念図を加えています。

肺炎の診療では、感染そのものの評価に加え、呼吸不全、循環不全、意識障害、脱水などの重症度判断が最優先となります。外来管理が適切か、入院が必要かは、年齢や併存症、在宅支援体制も含めて決定します。

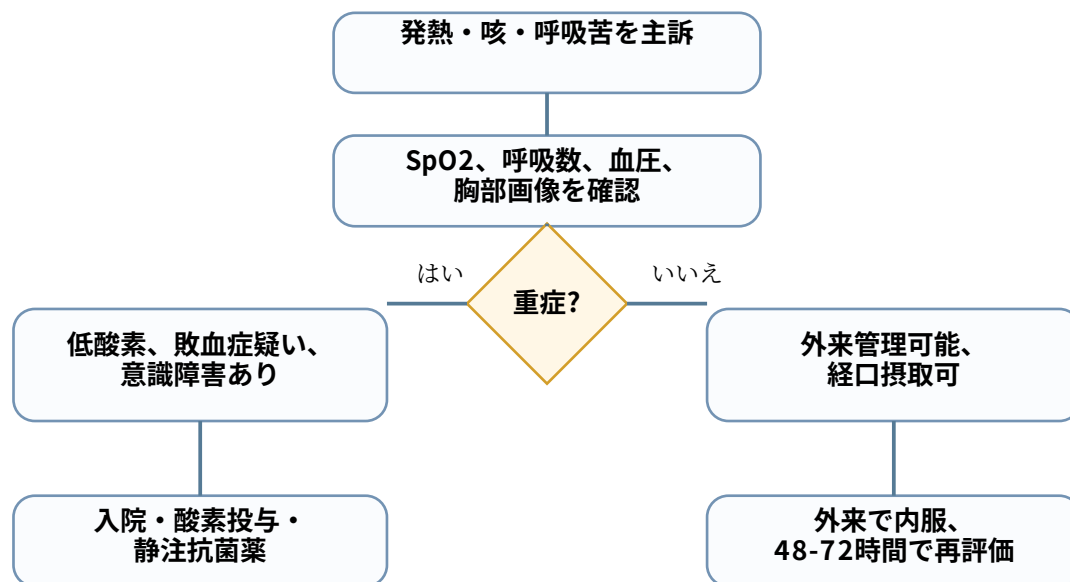
この文書で扱う視点

- 症状とバイタルサインの統合的評価
- 画像、酸素化、炎症反応の読み方の整理
- 抗菌薬開始後の再評価タイミング

臨床内容は教育用の一般化した説明です。実際の診療では地域のガイドライン、耐性菌リスク、基礎疾患、流行状況を参照してください。

2. 初期トリアージのフロー

下図は、肺炎が疑われる患者の重症度を大まかに仕分ける例です。SpO2、血圧、意識状態などは短時間で反復評価する必要があります。



フロー図には、日本語テキスト、矩形、判定菱形、接続線が含まれます。

3. ベッドサイド評価表

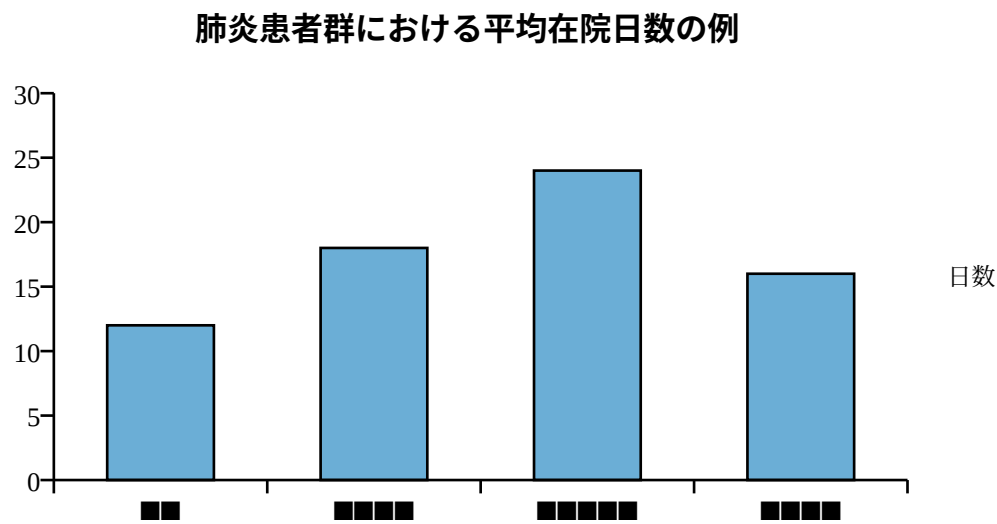
肺炎の重症度評価は、ひとつの数値だけで決まりません。バイタル、画像、患者背景をまとめて眺める必要があります。

指標	例	読み方
SpO2	90%	低酸素血症を示し、酸素投与を検討
呼吸数	30/分	重症化のサインになり得る
収縮期血圧	85 mmHg	循環不全や敗血症を疑う
意識状態	傾眠	重症として扱う
胸部X線	右下肺野浸潤影	病変分布や胸水を確認

表レイアウトは、短い数値列と長い解釈列を組み合わせた実務寄りの形にしています。

4. 集団ごとの在院日数の例

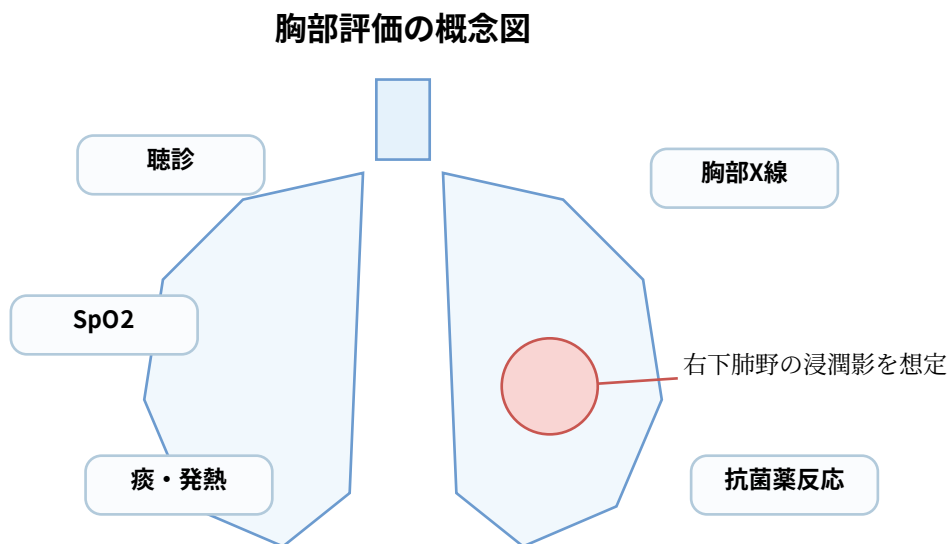
下図は架空データに基づく棒グラフです。病態だけでなく、ADL低下や退院先調整などの社会的要因が在院日数に影響しやすいことを示すための例示です。



棒グラフは、カテゴリ軸、日本語ラベル、数値目盛りの表示確認に有用です。

5. 胸部評価の概念図

肺炎診療では、病変の存在だけではなく、左右差、下肺野優位か、胸水や無気肺の合併がないかを意識します。概念図は胸部画像読影そのものではなく、観察の視点を整理するための図です。



概念図ページは、図形中心のページでも余白と文字サイズが自然に見えるかどうかを確認するのに適しています。

6. 抗菌薬選択の整理

抗菌薬は、重症度、誤嚥、既往歴、耐性菌リスク、腎機能、服薬アドヒアランスを踏まえて選びます。開始後は反応性と副作用をあわせて再評価します。

抗菌薬戦略	想定場面	メモ
外来の第一選択	若年で基礎疾患少ない	地域流行や耐性率を確認
入院一般病棟	酸素投与が必要	静注開始後、内服へ切替検討
誤嚥リスク高い	嚥下障害や意識障害あり	口腔ケアと栄養評価も重要
医療関連肺炎を考慮	耐性菌リスクあり	既往培養結果を参照

「想定場面」と「メモ」を並べることで、単なる薬剤名の列挙ではなく運用上の判断材料として読める形にしています。

7. 再評価の考え方

抗菌薬開始後 48 から 72 時間は、改善傾向の有無を判断する重要な時間帯です。解熱していなくても、呼吸数の低下、酸素需要の減少、食事摂取の改善など、全体として前向きな変化があるかをみます。

一方で、悪化している場合は、抗菌薬不応だけでなく、胸水増加、心不全、肺塞栓、薬剤熱、ウイルス感染、誤嚥の持続など鑑別を広く持つ必要があります。

高齢者では典型的な発熱や咳が目立たず、食欲低下やせん妄、転倒として現れることがあります。家族や介護スタッフからの情報を集めることが、診断の精度を大きく左右します。

文章主体ページとして、段落が複数続く場合の可読性や、ページ内の均整を確認できます。

8. 文書の確認項目

最後に、このPDFがテスト資料として十分かどうかを確認するための項目を示します。

- 図表と本文が同じページ内で自然に収まっていること
- 日本語の見出し階層がはっきりしていること
- 図形の線や塗りが欠けていないこと
- ページヘッダーとフッター位置が安定していること

項目	内容
ページ数	8ページ
言語	日本語
図表構成	表2点、フロー図1点、棒グラフ1点、概念図1点
主題	肺炎の初期評価と再評価

以上で文書Bを終了します。